

Integreeritud teenused laste vaimse tervise toetamiseks: ennetus, varajane märkamine ja õigeaegne abi



Tiina Tõemets

laste ja perede osakonna projektijuht, sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumis välja töötatud integreeritud teenuste kontseptsioon kirjeldab lastele ja peredele mõeldud teenuseid, mis toetavad lapse heaolu ja vaimset tervist ning haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna koostööd. Läbivad põhimõtted on perekeskne ja lapse vajadusi arvestav lähenemine, lahendustele orienteeritud valdkondadeülene koostöö, olemasolevate ressurssidega arvestamine, tõendus põhiste ja mõõdetavate tulemustega tegevuste arendamine. Artikkel annab ülevaate laste vaimset tervist toetavate teenuste olemusest ja arendamise suundadest, mis on kirjas valminud kontseptsioonis.

Väga varased mõjutused

Lapse õpivõime, suhted kaaslastega, turva- ja õnnetunne on tihedalt seotud täiskasvanute loodud füüsilise ja vaimse kasvukeskkonnaga. Lapse elu täisväärtuslikuks kujunemise määravad teda ümbritsevad inimesed, igapäevased kogemused ja rutiinid. Uuringud näitavad, et tegelikult saab laps mõjutusi juba ema raseduse ajal. Kriitilise tähtsusega on aga kolm esimest eluaastat, mil areng on kõige kiirem. Kolm väga olulist riskitegurit on:

- 1) pikaajaline stressi talumine (nt vanemate vahelised konfliktid, ema pidev muretsemine jm)
- 2) tähelepanu defitsiit (nt hoolitsuse ja

puudutuste nappus, lapse vajaduste eiramine)

- 3) vaesus ja kehvad kasvutingimused (nt menüü, kus pole piisavalt toitaineid, arendava keskkonna puudumine). (Heckman 2006, Shonkoff 2011)

Kui laps oskab oma käitumise ja sõnadega rahulolematust juba paremini väljendada, hakatakse uurima, mis on lahti. Siis tuleb välja selgitada, kuidas pere tervikuna toimib ja hinnata perekonna vajadusi. Tervikliku hindamise saab läbi viia KOV lastekaitsetöötaja. Kui abi saamiseks pöörduakse juba Rajaleidja keskusesse või vaimse tervise kabinetti, siis viib hindamise läbi sealne meeskond. Mõnikord on lastega töötavad spetsialistid varmad perekonda sildistama või usutakse, et vaimse tervise spetsialist suudab lapse „terveks” teha. Kui vanem pole koostööaldis, tuleb koostöösuhte nimel pingutada, et last aidata.

Eestis hakatakse lapse toimetuleku pärast tavaliselt tõsisemalt muretsema alles siis, kui laps läheb kooli. Sageli selgub koolipingis, et laps ei suuda keskenduda, tema sotsiaalsed oskused ei vasta kooli nõuetele või lapsele lihtsalt ei meeldi koolis käia. Loomulikult on ka siis veel võimalik efektiivselt sekkuda, kuid probleemide lahendamisele kulub juba rohkem aega ja ressursse.

Kuidas ära hoida probleemide süvenemist

Kõige tõhusam on panustada ennetustegevusse. Universaalne ennetus hõlmab kõiki Eestis elavaid lapsi. Juba enne lapse sündi tuleb toetada vanemate kohanemist uue rolliga ning vajadusel ka paarisuhet. Pärast lapse sündi toimivad hästi beebikooli sarnased tugirühmad, kus käsitletakse lapse arenguga seotud vajadusi ja oskusi. Selliste koolituste läbiviijad peavad olema professionaalid.

Riskirühma kuuluvate pere kaasamine eeldab ka kogukonna toetust. Iga pereni võimaldab jõuda regulaarne arsti- või pereõe külastus, mille käigus tuleks rohkem tähelepanu pöörata vanemlikele oskustele, pere toimimisele ja lapse vaimsele tervisele. Universaalne ennetus peab olema kõigile kättesaadav. Peamine on küsimus, kuidas kaasata sellesse kõik tuge vajavad perekonnad.

Riskirühmade puhul on tähtis rakendada varakult ka teisest ennetust ehk riskide maandamist. Mõnel juhul on vanemal vaja osaleda turvalise kiindumussuhte koolitusel „*Circle of Security*”¹ või arendada oma vanemlikke oskusi vanemlusprogrammis „Imelised aastad”². Kui nooruk on juba kaotanud usalduse ühiskonna vastu, siis on võimalik rakendada mitmedimensioonilist pereteraapiat, mida koordineerib Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksus. Kõigi nimetatud programmide tõhusust on hinnatud kas Eestis või teistes riikides, seega on tõenäosus saavutada soovitud muutusi suurem, kui juhuslikke sekkumisi ellu viies.

Lastele mõeldud tegevustena tasub veel nimetada sallivuse suurendamist ja kollektiivis vajalike sotsiaalsete oskuste harjutamist.

Kooliealised lapsed peavad oskama arvestada oma kaaslaste heaolu; mõistma, kuidas negatiivne käitumine mõjub neile endile ja teistele; neil peab olema julgust abi küsida ja usaldust täiskasvanute vastu. Selleks on kohandatud mitmeid tõendus põhiseid programme, nagu KiVa („Kiusamise vastu”)³ ja VEPA („Veel paremaks”) käitumiskoskuste mäng⁴. Neid viiakse läbi koolides, seni paraku projektipõhiselt. Riik ja omavalitsused peavad koos leidma lahenduse, kuidas teha need sekkumised kättesaadavaks igas asutuses, kus neid vajatakse.

Teisese ja kolmandase sekkumise (vt joonis 1, lk 68) puhul on võimalik rakendada ennetust siis, kui riskid on juba tuvastatud. Nii saab soodustada lapse ja vanema kiindumussuhet, arendada vanemlikke oskusi ja parandada lapse toimetulekuoskuseid.

Riskide ja abivajaduse hindamine

Kuna meie väikese riigi ressursid on piiratud, tuleb neid kasutada sihipäraselt. Õiget sekkumist aitab planeerida pere abivajaduse ja riskide võimalikult täpne hindamine. Enamasti kasutatakse intervjuu meetodit, intervjuueeritakse ühte või, veel parem, mõlemat vanemat ja kindlasti last. Levinud on ka andmete kogumine lapsega kokku puutuvate spetsialistide abiga. Tõhus võiks olla võrgustiku koostöö, kus osalised kohtuvad ja leiavad koos parima lahenduse. Probleemi täpsustamisel oleks abi standardiseeritud hindamisvahenditest. Nii saab hinnata vajadust kasutada logopeedi või eripedagoogi, ennetusprogramme, pereteraapiat jms.

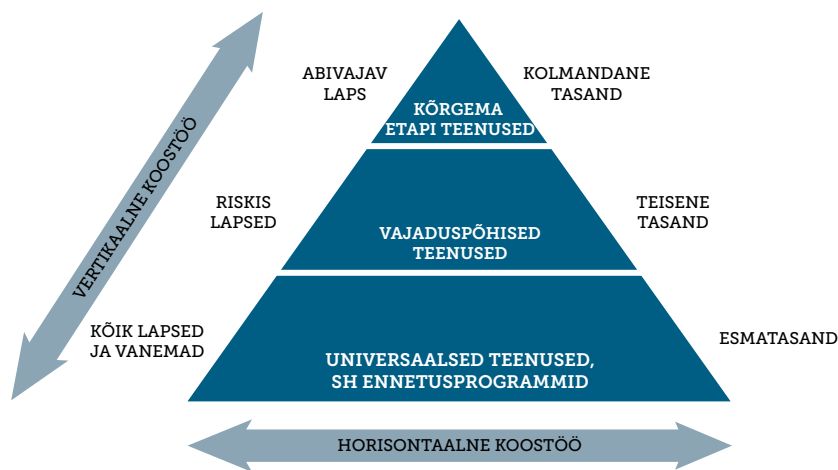
Soovitav oleks kasutada universaalseid

¹ Loe lähemalt www.perenou.ee/circle-of-security-vanemakoolitus.

² Loe lähemalt www.tai.ee/vanemlusprogramm.

³ Loe lähemalt www.kivaprogram.net/estonia.

⁴ Loe lähemalt www.terviseinfo.ee/vepa.



Joonis 1. Integreeritud teenused kolmel tasandil

sõelumisvahendeid⁵, see tagab võrdse kohtlemise ja aitab vältida subjektiivsete hinnangute andmist. Praegu standardiseeritud hindamisvahendeid laste vaimse tervise ja heaolu hindamisel Eestis teadaolevalt veel ei kasutata (Akkermann 2014). Küll aga on uuritud rahvusvaheliselt kasutatavaid küsimustikke, mille usaldusväärsus on teaduslikult kinnitatud. Mõne küsimustiku kohandamist Eesti oludele on juba alustatud. Esimestena valiti välja M-CHAT-R/F, millega sõelutakse kaheaastaste laste autismispektri-häire kahtlust ning PSOC (*Parenting Sense of Competence*) vanemliku rahulolu hindamiseks. Aasta lõpuks saab kohandatud veel KIDSCREEN-52, mis laseb õpilasel oma heaolu hinnata ja FFSS (*Family Functioning Style Scale*), mis näitab perekonna tugevusi, aga ka toetusvajadust. Laste ja perede osakond kohandab lastekaitsetöötajatele ühtset ter- viklikku hindamisraamistikku, mis on pärit Ühendkuningriigist ja kasutusel ka Rootsis. Praegu on veel lahendamata küsimus, kus

peaksid standardiseeritud hindamisvahendid paiknema, et neid saaksid kasutada kõik lapse ja perega tegelevad spetsialistid. Riik on probleemi teadvustanud: otsitakse võimalikku IT-lahendust ning kavandatakse arendus- ja koolitustegevust.

Vajalik tugi ja teenuste integreeritus

Selleks et osutada eri valdkondade teenuseid integreeritult, ei ole alati vaja täpseid ettekirjutusi. Ühes heas näites märkas võrgustiku liige õigel ajal lapse probleemi ja kaasas koostööpartnereid, kes korraldasid sekkumisi. Lasteaiaõpetaja märkas mahajäämust lapse arengus ja teavitas sellest kõigepealt vanemaid, kuid perekond ise ei leidnud lapsele abi. Seejärel kaasas lasteaed lastekaitsetöötaja, kes suhtles perekonnaga ja aitas leida spetsialisti, kes sai last aidata. Kohalik omavalitsus korraldas transpordi spetsialisti vastuvõtule. Lapsele koostati raviplaan, lasteaia personal sai soovitusi lapse toetamiseks. Selles loos oli

⁵ Universaalsed sõeltestid on standardiseeritud hindamisvahendid probleemi varajaseks avastamiseks, nende abil viiakse läbi kõigi antud vanusgruppi kuuluvate laste hindamine.

lasteaiatõpetaja sekkumise algataja, lastekaitsetöötaja korraldaja, spetsialistid osutasid vajalikke teenuseid ning andsid tagasisidet perekonnale, haridusasutusele ja kohaliku omavalitsuse töötajale. Järgepideva toetuse tagamiseks teeb järelevalvet lastekaitsetöötaja. Perekonnal oli toimetulekuraskusi, kuid neile leiti lahendusi ja laps sai õigel ajal abi.

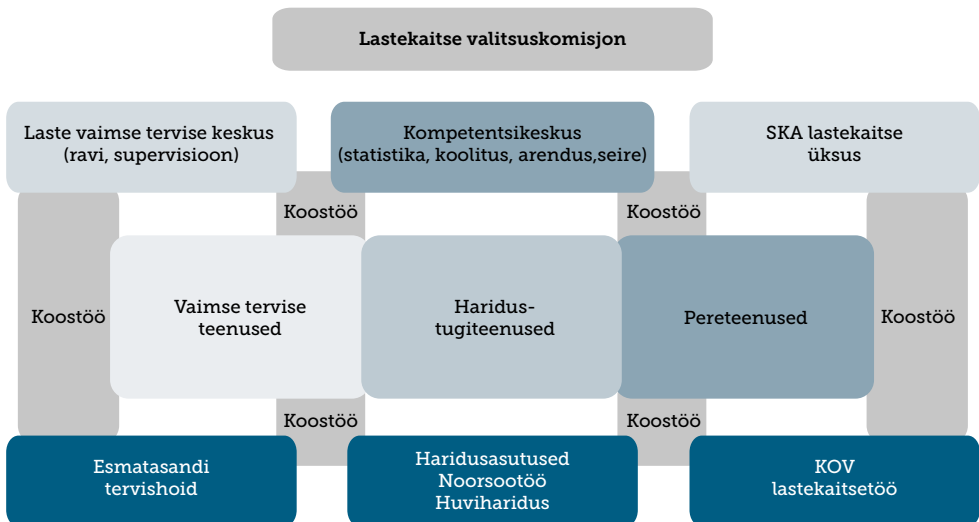
Niisugune koostöövõrgustik peaks toimima igas kohalikus omavalitsuses ja reageerima vajaduspõhiselt. Selle korraldamiseks saab muuta seadusandlust ja luua juhiseid, kuid veel tähtsam on muuta abistajate suhtumist ja soovi leida ühiselt tõhusaid lahendusi, kuidas lapse heaolu tagada.

Alati ei saa kõiki muresid nii loogiliselt lahendada. Sellisel juhul vajavad lastega töötavad spetsialistid ja võrgustikud toetust. Keeruliste juhtumite lahendamisel saab lastekaitsetöötaja tuge ja nõu regionaalsest lastekaitseüksusest, mis kuulub Sotsiaalkindlustusameti juurde. Samasugust tugisüsteemi vajaksid ka õpetajad, hariduses töötavad tugispetsialistid, vaimse tervise teenuse osutajad ja esmatasandi tervishoiutöötajad.

Laste vaimse tervise probleeme aitavad lahendada vaimse tervise keskused nii Tallinnas, Tartus, Pärnus kui ka Ida-Virumaal. Et abi lähemale tuleks, katsetati laste vaimse tervise kabinetide toimimist Soome näitel Põlva, Võru ja Valga maakonnas. Kabinet aitab kiireloomuliste probleemide puhul ja diagnoosikahtlusega lapsel kiiremini psühhiaatrilist abi saada ning nõustab ja jõustab juhtumeid, mida tegelikult saab lahendada lapse elukohas. Tulevikus on plaanis avada kabinetid igas maakonnas. Hariduslike erivajadustega ja õpiraskustega lapsi toetavad Rajaleidja keskused.

Praeguses süsteemis puudub veel läbimõeldud pereteenuste korraldus. Erandiks on suuremad linnad, kus omavalitsus toetab neid teenuseid, mis perekonda keerulistel aegadel aitavad. Pereteenustest võib välja tuua pereteraapiat, perelepitust, aga ka individuaalset vanemluse nõustamist või psühholoogilist toetust (vt joonis 2).

Teenuste integreeritus on paljuski kokkuleppeline ja tähendab, et perega seotud osalised teevad tihedat koostööd selle nimel, et perekond saaks abi ja tuleks edaspidi iseseisvalt



Joonis 2. Tervikvaade integreeritud teenustele laste vaimse tervise toetamiseks

toime. Koostööd ilmestab ühine tegevusplaan, kus on ära toodud planeeritavad sekkumised ja nende elluviimise eest vastutajad. Lepitakse kokku kohtumiste regulaarsus ja teenuste maht, et tagada ülevaade toimuvast. Tähtis on, et igal juhtumil on algus ja lõpp. Lõpetatuks ei saa lugeda tegevust, kus perekond ja lapsega töötavad spetsialistid ei näe positiivset muutust. Väljatoomist ja tunnustust vajavad aga väiksemad ja suuremad edasimineked ning positiivsed muutused lapse käitumises. Koostöövõrgustik ei saa olla formaalne, tarvis on reaalselt tugisüsteemi, mis aitab keeruliste olukordadega edukalt toime tulla.

Kokkuvõtteks

Laste vaimse tervise toetamiseks on kõige kasulikum teadlikult ennetada probleemide tekkimist. Selleks peab riik tugedama igasuguseid ennetusega seotud tegevusi. Riskirühma kuuluvate laste toetuseks on

vaja valdkondadevahelisi ja tõendus põhiseid sekkumisi, et probleeme märgataks aegsasti ja abi jõuaks korraldada õigel ajal. Tähtis on määrata juhtumikorraldaja, kes jälgib, et kokkulepitud tegevused saaksid ellu viidud, et need oleksid asjakohased ja probleemid saaksid tõhusa lahenduse.

Juba on astutud mitmeid olulisi samme: välisvahendite toel on alustatud valdkondadevahelise tegevuse koordineerimist, ka tõendus põhised sekkumised on muutunud kättesaadavamaks. Uus lastekaitse seadus kohustab iga lastega töötavat spetsialisti märkama abivajavat last. Sealt algabki võimalus pakkuda igale lapsele turvalist ja toetatud kasvukeskkonda.

Olemasolevad ressursid ja oskused tuleb põimida terviklikult toimivaks süsteemiks, kus iga spetsialist teab oma rolli ja vastutust ning iga perekond tunneb, et vajadusel neid mõistetakse ja osatakse probleeme lahendada. **S**

Kontseptsiooni tervikteksti ja teised projekti „Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise parandamiseks” raames valminud materjalid leiata sotsiaalministeeriumi koduleheküljel www.sm.ee -> Eesmärgid ja tegevused ->

Lapsed ja pere -> Lapse õigused ja heaolu.

Projekti viiakse ellu Norra toetusel programmi „Rahvatervis” varem kindlaksmääratud tegevusena.

Viidatud allikad

- Akkermann, K.** (2014). Lapse heaolu ja vaimse tervise hindamisvahendite kaardistamise lõppraport. Tallinn: Sotsiaalministeerium. www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Lapse_oigused_ja_heolu/hindamisvahendite_loppraport_veebruar_2015.pdf (25.11.2016).
- Heckman, J. J.** (2006). Skill formation and the economics of investing disadvantaged children. *Science*, 312, 1900–1903.
- Shonkoff, J. P.** (2011). Protecting brains, not simply stimulating minds. *Science*, 333, 982–983.